

Hipertensão arterial - crise e crônica

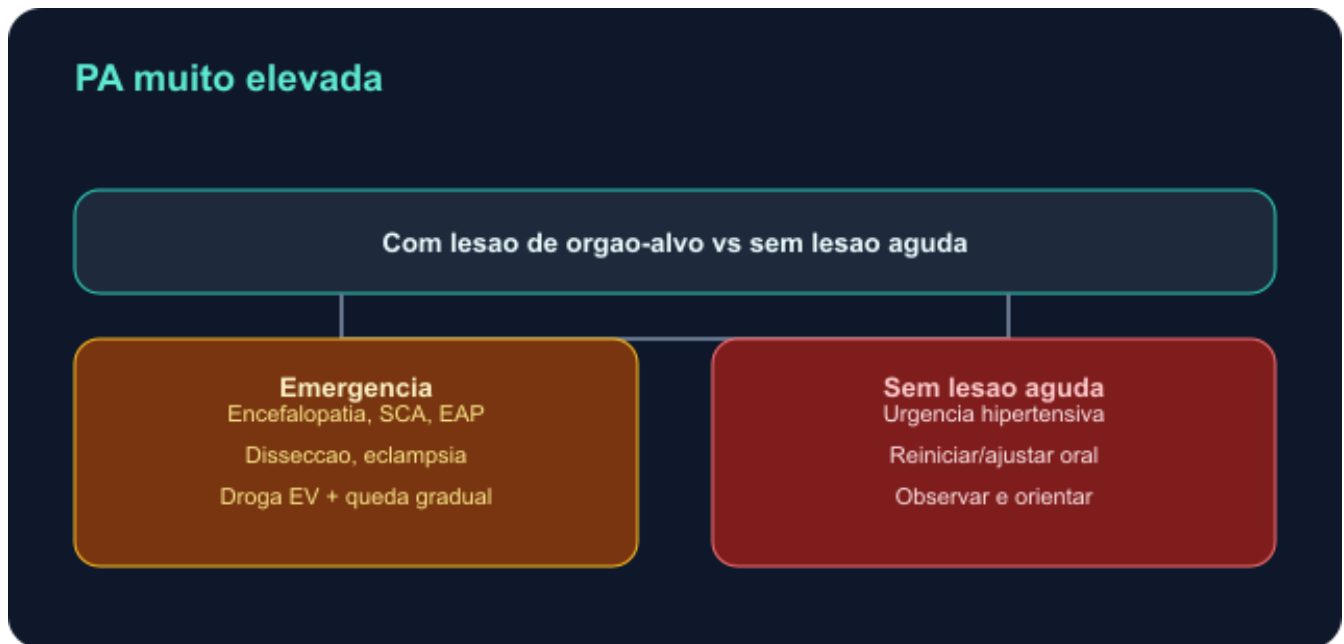
Separe HAS crônica (adesão e combinação) de emergência hipertensiva (lesão de órgão-alvo aguda). Na emergência, reduza PA de forma controlada — não 'normalize' em minutos.

Combinação inicial

Dica - Combinação inicial

Em estágios mais altos ou risco CV, prefira associação (IECA/BRA + BCC ou tiazídico). Monoterapia raramente basta quando PA está muito acima da meta.

Ramificação: lesão aguda = emergência (EV, UTI); sem lesão = urgência/ajuste oral e investigação.



Pontos de conduta crônica

- Confirmar com MAPA/MRPA quando dúvida diagnóstica ou efeito do avental branco
- IECA/BRA: preferir em DM, proteinúria, IC; monitorar creatinina e K z
- Betabloqueador: não é 1ª linha isolada salvo pós-IAM, FA, IC
- Investigar secundária se início jovem, resistente, hipoK, sopro ou piora abrupta

Emergência — exemplos de droga

Cenário | Preferência clássica

EAP hipertensivo | Nitroglicerina / nitroprussiato

SCA | Nitrato + betabloqueador se apto

Dissecção de aorta | Betabloqueador primeiro, depois vasodilatador

Encefalopatia hipertensiva | Nitroprussiato / nicardipino (queda controlada)

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não use nifedipina sublingual de 'rescate' na emergência hipertensiva — queda imprevisível e risco isquêmico. Evite reduzir PA >25% na 1ª hora (exceto dissecção/eclampsia, com metas específicas).